



Método
Cristina Petratti

GUÍA GRATUITA

«Dejé la medicación y recuperé todo el peso. Fracasé.»

No. No fracasaste.

Lo que le pasa a tu cuerpo al dejar el tratamiento, por qué no es culpa tuya y qué consolidar antes de decidir nada.

Dra. Cristina Petratti · Médica de familia · Especialista en obesidad · SEEDO
Autora de «Obesidades sin culpa» · Creadora del Método Petratti

Esta guía es divulgativa y general. No sustituye a tu médico/a ni a quien te prescribe. Cualquier decisión sobre continuar, reducir o retirar un tratamiento se toma con historia clínica y supervisión.

1 · Lo que midió un ensayo clínico cuando se retiró el tratamiento

En un ensayo con un agonista del receptor GLP-1 (arGLP-1), 327 personas dejaron el tratamiento tras 68 semanas y fueron seguidas un año más, hasta la semana 120. Todo ello con dieta y ejercicio supervisados dentro del propio ensayo.

Momento	Peso perdido (media)	Qué pasó
Semana 68 (con tratamiento)	17,3 %	Mejoraron presión arterial, glucosa y lípidos
Semana 120 (un año sin tratamiento)	5,6 %	Se recuperaron dos tercios del peso perdido; las mejoras cardiometabólicas revirtieron

Fuente: Wilding JPH, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: the STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022;24:1553-1564. Se cita el principio activo por rigor científico, no como recomendación.

2 · Por qué vuelve el peso: no es carácter, es fisiología

La obesidad es una enfermedad crónica en la que participan el cerebro, las hormonas, el metabolismo, el entorno y las emociones. Cuando pierdes peso, tu cuerpo responde para recuperarlo:

- Baja la leptina, la hormona que avisa al cerebro de que hay reservas suficientes. El cerebro interpreta escasez.
- Sube la grelina, la hormona del hambre. Tienes más apetito y menos saciedad.
- Cae el gasto energético por debajo del que corresponde a tu nuevo peso. Gastas menos haciendo lo mismo.
- Estas adaptaciones persisten más de un año después de la pérdida de peso.

Un arGLP-1 actúa sobre parte de estas señales (saciedad, apetito). Al retirarlo, las señales vuelven. Eso no es un fallo tuyo: es lo que hace una enfermedad crónica cuando se retira un tratamiento sin haber consolidado lo que sostiene el resultado.

Fuentes: Sumithran P, et al. N Engl J Med. 2011;365:1597-604 · Fothergill E, et al. Obesity. 2016;24:1612-9 · Comisión Lancet sobre obesidad clínica, 2025.

3 · Los cuatro pilares que sostienen el resultado

El error no es dejar el tratamiento: hay casos en los que se valora. El error es dejarlo de golpe, sin plan y sin haber construido esto. Son orientaciones generales para población adulta; tu médico/a las adapta a tu caso.

Fuerza	El músculo es el tejido que más protege el metabolismo tras perder peso. Las guías recomiendan al menos dos sesiones semanales de fuerza para todos los adultos. Empezar con el propio peso corporal cuenta.
Proteína	Durante y después de la pérdida de peso, un aporte proteico suficiente y repartido en las comidas ayuda a conservar masa muscular y a la saciedad. La cantidad exacta depende de tu peso, tu riñón y tu situación: se calcula en consulta.
Sueño	Dormir menos de siete horas altera leptina y grelina y aumenta el hambre al día siguiente. Horario regular, luz de mañana y pantallas fuera de la cama son el primer escalón.
Estrés y emociones	El cortisol crónico y el hambre emocional no se resuelven con fuerza de voluntad. Se trabajan con herramientas concretas: identificar disparadores, pausas, apoyo. Es el pilar más olvidado y el que más sostiene.

Fuentes: OMS, Directrices sobre actividad física, 2020 · Guía europea EASO de manejo de la obesidad en adultos · Chaput JP, et al. Sleep and obesity, 2023.

4 · Antes de decidir nada sobre el tratamiento

- No lo dejes por tu cuenta ni de golpe. Cuándo y cómo lo decide quien te prescribe, con tu historia clínica delante.
- No lo retomes por tu cuenta. Tampoco con restos de dosis anteriores ni por internet.
- Si notas vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, mareo o desmayo, acude a urgencias. Si sospechas una reacción a un medicamento, tu médico/a puede notificarla.
- Lleva a tu consulta esta pregunta: «¿Qué tengo consolidado y qué me falta antes de cambiar el tratamiento?»

5 · Qué haría yo contigo en una Sesión de valoración

Repasar tu historia del peso desde el principio, no desde el último intento. Los tratamientos que has llevado y qué pasó al dejarlos. Tu sueño, tu cintura, tu relación con la comida y tu analítica. Y salir con un diagnóstico de dónde estás y un plan con los tres pilares del Método: alimentación flexible, ejercicio adaptado y gestión emocional. Con o sin tratamiento farmacológico, porque el Método trabaja lo que el fármaco no hace.

Reserva tu Sesión de valoración

45 minutos · online · sin coste

Miramos tu historia completa, con historia clínica, y sales con un plan.

<https://calendly.com/metodopetratti-info/30min>



No valoro casos ni analíticas por mensaje directo: es tu seguridad y mi deontología. En la sesión sí, con historia clínica.

Si esta guía te ha servido, compártela con esa persona que dejó el tratamiento y se está culpando. Necesita leer esto.

Dra. Cristina Petratti · Médica de familia · Especialista en obesidad · Miembro de SEEDO · Autora de «Pierde peso» y «Obesidades sin culpa» · Creadora del Método Petratti · Instagram @crispetratti · YouTube @dra.cristinapetratti